

Ein autistischer Erwachsener / eine autistische Erwachsene in Ihrer Praxis

Für Hausärzt:innen und Gesundheitsberufe — Versorgung eines autistischen Erwachsenen in Beschäftigung.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines Erwachsenen in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. In der richtigen Umwelt bringt das echte Stärken — anhaltende Konzentration, Verlässlichkeit, Mustererkennung, Tiefe und Ehrlichkeit. In der falschen (Großraumbüros, ständige Unterbrechung, unklare Erwartungen, Büropolitik) treibt es chronische Erschöpfung, Masking und **autistisches Burnout**. Viele berufstätige autistische Erwachsene — besonders Frauen — wurden erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Ein 15-Minuten-Termin zeigt selten die wahren Kosten.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Erschöpft, erholt sich nach der Arbeit nicht, verliert Kompetenzen	Autistisches Burnout — von beruflichem Burnout und von Depression zu unterscheiden
Angst, gedrückte Stimmung, Schlaf- oder GI-Probleme	Häufige Ko-Vorkommen und Überlastungssignale
In der Praxis „gut“, bricht tagelang danach zusammen	Starkes Masking ; die wahren Kosten werden ungesehen gezahlt
Meldet Schmerz, Symptome oder Nebenwirkungen erst, wenn schwer	Interozeptions -Unterschiede — innere Signale registrieren sich vielleicht nicht, wenn vertieft
Will E-Mail statt Anrufe; braucht Dinge schriftlich	Eingekanalige, wörtliche Kommunikation senkt die Last

Versuchen Sie dies

- **Bieten Sie das AASPIRE AHAT** vorab und **schriftlich-zuerst**-Optionen; erlauben Sie eine Begleitperson.
- **Erkennen Sie autistisches Burnout** — chronische Erschöpfung, Funktionsverlust, verminderte Reiztoleranz — und verwechseln Sie es nicht mit Depression oder Faulheit.
- **Fragen Sie nach Arbeitsplatz-Last und Erholung**: Großraum, Meetings, Unterbrechungen, Masking.
- **Medikamente niedrig beginnen und langsam titrieren** — autistische Erwachsene berichten oft atypische sensorische/emotionale Reaktionen.
- **Verweisen Sie auf Arbeitsplatz-Anpassungen** (Gleichbehandlungsgesetz / ADA) und legen Sie nahe, die Person sei die Expertin für das, was hilft.

Vermeiden Sie dies

- Burnout als Depression behandeln und die Patientin / den Patienten zum „mehr anstrengen“ oder Masken drängen — das vertieft es und erhöht das Suizidrisiko.
- Eine ruhige, maskierte 15 Minuten über Selbstbericht und Anamnese stellen.

- Annehmen, „nicht klagen“ bedeute „nicht leiden“.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Untersuchen Sie auf **Suizidalität** — Burnout ist damit verknüpft. Behandeln Sie begleitende **ADHD (AuDHD), Angst, Depression, Schlaf- und GI-Zustände**. Wo Burnout schwer ist, validieren Sie **Auszeiten oder reduzierte Erwartungen** als Erholungsschritt, nicht als Schwäche. Dokumentieren Sie wirksame Anpassungen, damit sie beim nächsten Mal automatisch sind.

Wenn die Patientin / der Patient eine Frau ist

Frauen sind unter der „verlorenen Generation“ spät-diagnostizierter Erwachsener überrepräsentiert und masken am stärksten. Nehmen Sie ein lebenslanges Muster sozialer/sensorischer Unterschiede und privater Erschöpfung ernst, auch bei einem „erfolgreichen“ Äußeren.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — das **Monotropismus**-Dossier und der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teile 3.4 & 4). Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022, Burnout-Schutzfaktoren); Pearson & Rose (2021, Masking); Knight (2021); Kelly Mahler (2024, Interozeption); AASPIRE AHAT. Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.